

UFSC – SC – 2010

Residência Médica R3 – CIRURGIA

Prova com 40 questões · Documento gerado a partir de provaderesidencia.com.br

1. Das alternativas abaixo, assinale a que mais sugere o diagnóstico de abdome agudo obstrutivo:

- A)** Vômitos, febre e leucocitose.
- B)** Dor contínua, tontura e vômitos.
- C)** Distensão abdominal, dor em cólica, antecedente de cirurgia no abdome.
- D)** Distensão abdominal, febre, dor contínua e vômitos.
- E)** Sinais de irritação peritoneal, hipotensão e taquicardia.

2. Em relação ao suporte nutricional do paciente cirúrgico, é correto afirmar:

- A)** Idade, sexo, peso e altura são variáveis consideradas no cálculo do gasto energético basal.
- B)** Somente os pacientes com perda ponderal acima de 10% do peso usual são candidatos a suporte nutricional parenteral.
- C)** Na pancreatite aguda grave, a nutrição parenteral deve ser considerada precocemente, para evitar atrofia dos enterócitos.
- D)** Após esofagectomia, está indicado suporte nutricional apenas nos casos de fístula da anastomose.
- E)** Nos casos de fístula intestinal, prefere-se a nutrição enteral para evitar translocação bacteriana.

3. Em casos de obstrução intestinal alta, quais dos distúrbios hidroeletrolíticos abaixo são mais frequentes?

- A)** Hipocalcemia e hiponatremia.
- B)** Hipernatremia e hipocalcemia.
- C)** Hiperidratação e hipomagnesemia.
- D)** Desidratação e hipopotassemia.
- E)** Desidratação e hiponatremia.

4. Enquanto a incidência do Câncer de Esôfago na China é de 240 casos/ano por 100mil habitantes, no Brasil é de:
- A) 7 casos/ano por 100 mil habitantes.
 - B) 30 casos/ano por 100 mil habitantes.
 - C) 80 casos/ano por 100 mil habitantes.
 - D) 120 casos/ano por 100 mil habitantes.
 - E) 150 casos/ano por 100 mil habitantes.
5. Hérnia Interna pelo espaço de Petersen tem maior incidência após:
- A) gastro-jejunoanastomose pré-cólica em gastrectomia parcial por úlcera péptica.
 - B) gastro-jejunoanastomose pré-cólica em cirurgia bariátrica.
 - C) gastro-jejunoanastomose pré-cólica em gastrectomia sub-total por câncer gástrico.
 - D) colecisto-jejunoanastomose pré-cólica por CA de pâncreas em estágio avançado.
 - E) hepático-jejunoanastomose pré-cólica por estenose das vias biliares.
6. A dosagem da alfafetoproteína (AFP) praticamente confirma o diagnóstico de Hepatocarcinoma, quando está acima de:
- A) 50 ng/ml.
 - B) 90 ng/ml.
 - C) 100 ng/ml.
 - D) 120 ng/ml.
 - E) 200 ng/ml.
7. Com relação aos cistos no mesentério, no omento e no retroperitônio, assinale a alternativa correta:
- A) Em crianças, são mais frequentes antes dos 02 anos.
 - B) Os cistos do retroperitônio representam 25% das lesões císticas abdominais.
 - C) A marsupialização é sempre recomendável para esses tipos de cistos.
 - D) Cistos mesentéricos são mais frequentes e localizam-se principalmente no mesentério do íleo terminal.
 - E) Todos esses cistos são lesões relativamente frequentes e podem ocorrer em qualquer idade.

8. Dentre as complicações pós-transplante hepático, a menos frequente é:
- A) complicações biliares.
 - B) episódios de rejeições agudas e crônicas.
 - C) obstrução da veia cava inferior.
 - D) hemorragia intra-abdominal.
 - E) estenose da artéria hepática.
9. Na investigação do trauma abdominal, a laparoscopia é mais bem indicada no caso de:
- A) gestação.
 - B) hipertensão intracraniana.
 - C) pneumotórax hipertensivo.
 - D) instabilidade hemodinâmica.
 - E) diminuição do período de observação clínica em casos duvidosos.
10. No paciente politraumatizado, é indicação absoluta de toracotomia na sala de emergência:
- A) parada cardíaca no hospital em doente com trauma fechado de torax.
 - B) assistolia à admissão hospitalar não relacionada a tamponamento cardíaco.
 - C) ausência de sinais vitais no local do acidente.
 - D) doente com suspeita de tamponamento cardíaco com pressão sistólica menor que 60mmHg e bradicardia.
 - E) idade avançada.
11. Na cirurgia do trauma hepático, a realização de uma "mesh wrapping" significa:
- A) tamponamento do fígado com compressas.
 - B) oclusão das lesões com epiplon pediculado.
 - C) envolvimento do lobo hepático com tela absorvível e fixação da mesma para comprimir lesões hepáticas.
 - D) hepatectomia com ligadura dos vasos sangrantes.
 - E) hepatorrafia e cola de fibrina.

12. Com relação às lesões traumáticas do esôfago, é correta a alternativa:

- A)** o tórax sempre deve ser drenado.
- B)** nas lesões penetrantes do pescoço, o esôfago é atingido em torno de 4% dos casos.
- C)** o trauma contuso é mais comum que o penetrante como causa de lesão esofágica.
- D)** o esôfago abdominal é o mais atingido.
- E)** a evolução das lesões esofágicas cervicais são mais graves que as torácicas.

13. Com relação a síndrome de Budd-Chiari, assinale a alternativa verdadeira:

- A)** Pode estar associada à polecitemia vera.
- B)** O anticoncepcional oral não é um fator de risco.
- C)** O parênquima hepático é largamente atingido por fibrose.
- D)** A radiografia simples de abdômen não mostra alterações.
- E)** Não acarreta hipertensão portal.

14. Com relação ao íleo biliar, podemos afirmar que:

- A)** A mortalidade é em torno de 5%.
- B)** Os homens são os mais acometidos.
- C)** A idade média de acometimento é 70 anos.
- D)** Raramente temos obstrução intestinal.
- E)** No tratamento inicial, a vesícula biliar sempre é retirada.

15. Na pneumatose cística intestinal, é correto afirmar:

- A)** O cólon não é acometido.
- B)** O mesentério sempre está preservado.
- C)** A sintomatologia é grande e específica.
- D)** Na maioria dos casos ela é primária e não secundária.
- E)** Uma causa é a doença pulmonar obstrutiva crônica.

16. É correto afirmar sobre a oclusão mesentérica aguda:

- A)** A mortalidade é de no máximo 15%.
- B)** A dor abdominal é severa e localizada.
- C)** Sangue nas fezes surge precocemente.
- D)** A ingestão de cocaína é uma das causas.
- E)** A radiografia simples de abdômen diagnostica pelo menos 50% dos casos.

17. Na anomalia da junção bílio-pancreática, é correto afirmar:

- A)** É mais comum no Chile.
- B)** Acomete de 5-8% das pessoas.
- C)** Ela é um fator protetor para câncer de vesícula.
- D)** A colecistectomia não faz parte do seu tratamento.
- E)** Ocorre quando o canal comum entre a via biliar e o ducto pancreático principal é maior que 15 mm.

18. Nas verminoses da via biliar, é correto afirmar:

- A)** A clonorquíase é mais comum nas Américas.
- B)** Na equinococose, podemos ter obstrução completa da árvore biliar.
- C)** O ascaris lumbricoides é o segundo helminto mais comum do homem.
- D)** Na ascaridíase bílio-pancreática, a colangite é o sintoma mais comum.
- E)** Na fasciolíase, os vermes atingem a árvore biliar através da papila duodenal.

19. O antígeno carcinoembrionário (CEA) é usado em câncer colorretal com o objetivo de:

- A)** Realizar diagnóstico de câncer.
- B)** Realizar rastreamento populacional para câncer colônico.
- C)** Sugerir recidivas em paciente tratado por câncer.
- D)** Sugerir diferença entre patologia benigna e maligna.
- E)** Não ocorrer em doença benigna, fumantes etc.

20. Um paciente do sexo masculino, 65 anos, foi submetido a retirada colonoscópica de pólipó sésil, com 1,5 cm de diâmetro, de cólon sigmoide. O exame anatomopatológico mostrou adenoma túbulo-viloso com áreas de adenocarcinoma moderadamente diferenciado que atinge a mucosa e, em 10% da lesão, a submucosa. Qual a conduta?

- A)** Observação e colonoscopias anuais.
- B)** Observação e colonoscopias semestrais.
- C)** Sigmoidectomia se houver recidiva da lesão.
- D)** Sigmoidectomia e esvaziamento ganglionar.
- E)** Mucosectomia colonoscópica da área afetada.

21. Considere um paciente, 18 anos, com trauma perfurante de reto, por PAF há 2 horas, sem outras lesões associadas, localizado a 12 cm da margem anal. Qual a conduta cirúrgica?

- A)** Ráfia primária.
- B)** Cirurgia de Hartmann.
- C)** Colostomia em sigmoide.
- D)** Colostomia em sigmoide, drenagem pré-sacra, lavagem do segmento distal (sigmoide e reto) com soro fisiológico, saindo pelo canal anal.
- E)** Ráfia primária e estoma de proteção.

22. Quando há discromia pós queimadura significa que:

- A)** Houve destruição do melanócito.
- B)** A espessura da cicatriz bloqueia a luz e a pigmentação.
- C)** A isquemia final é a responsável pela hipocromia.
- D)** Houve fixação de pigmentos no citoplasma do histiócito.
- E)** A descamação repetida provoca a proliferação de fibroblasto e há conseguinte hiperpigmentação.

23. Na queimadura por gases aquecidos, o fenômeno da respiração fica prejudicado:

- A)** Pelo edema da árvore brônquica e lábio.
- B)** Pelo edema da glote e pela obstrução nasal.
- C)** Pelo edema da parede e interstício alveolar.
- D)** Pelo déficit circulatório em razão da perda de plasma.
- E)** Pela falta de filtração renal e alta concentração de catabólitos.

24. Tipo de carcinoma basocelular mais propenso a dar metástases linfonodais:

- A)** Ulcerado.
- B)** Superficial.
- C)** Pigmentado.
- D)** Basoescamoso.
- E)** Nódulo-ulcerado.

25. Em relação aos tumores de células germinativas do testículo, assinale a alternativa correta:

- A)** Cerca de 30% dos seminomas são clinicamente confinados ao testículo.
- B)** Cerca de 30% dos tumores não seminatosos se apresentam como doença metastática reconhecida.
- C)** A radioterapia é a forma de tratamento mais amplamente aceita após a orquiectomia inguinal nos tumores não seminatosos.
- D)** A linfadenectomia retroperitoneal é a modalidade de tratamento mais usada nos tumores seminomatosos após a orquiectomia inguinal.
- E)** Diagnóstico histológico é o fator mais importante na história natural da neoplasia testicular.

26. O processo de lise da ureia por bactérias fornece um meio urinário alcalino e concentrações suficientes de carbonato e amônia para induzir a formação de cálculos infectivos. Assinalar qual grupo de bactérias apresenta maior capacidade de desdobrar a ureia:

- A)** Proteus, Klebsiella, Pseudomonas e Stafilococcus.
- B)** Proteus, Klebsiella, Pseudomonas e E. coli.
- C)** Proteus, Klebsiella, E. coli e Stafilococcus.
- D)** Proteus, E. coli, Pseudomonas e Stafilococcus.
- E)** E. coli, Klebsiella, Pseudomonas e Stafilococcus.

27. A hiperplasia prostática benigna (HPB) deve-se à hiperplasia estromatoglandular, e é condição muito frequente em homens com mais de 50 anos. Com relação ao tema, assinalar a alternativa correta:

- A)** O desenvolvimento da HPB não requer a presença intacta de uma série de reações, mantidas pelos andrógenos, mas os andrógenos causam a doença.
- B)** O desenvolvimento da HPB requer a presença intacta de uma série de reações mantidas pelos andrógenos, mas os andrógenos não causam a doença.
- C)** O desenvolvimento da HPB independe dos andrógenos.
- D)** O desenvolvimento da HPB requer a presença intacta de uma série de reações mantidas pelos andrógenos, e os andrógenos causam a doença.
- E)** O desenvolvimento da HPB não requer a presença intacta de uma série de reações mantidas pelos andrógenos, mas os andrógenos não causam a doença.

28. Assinale o subtipo de carcinoma brônquico que se caracteriza por apresentar crescimento na parede das vias aéreas distais (lepidic grown), preservando a arquitetura pulmonar, fazendo por vezes diagnóstico diferencial com pneumonia.

- A)** Adenocarcinoma metastático.
- B)** Carcinoma espinocelular.
- C)** Carcinoma de células grandes.
- D)** Carcinoma de células pequenas.
- E)** Carcinoma bronquioloalveolar.

29. Um paciente de 50 anos, sexo masculino, chega ao ambulatório com queixas de dor torácica à direita, astenia, anorexia e emagrecimento. O exame físico não apresenta grandes alterações. Uma radiografia de tórax é realizada e mostra uma massa em mediastino anterior. A tomografia computadorizada mostra uma massa em mediastino anterior, tocando a parede anterior do tórax, de 10 cm de diâmetro, limites imprecisos, circundando o tronco braquiocéfálico venoso em mais de 270 graus e com desaparecimento dos planos de clivagem do mediastino. Qual a principal hipótese diagnóstica e o primeiro procedimento a ser realizado?

- A)** Timoma grau I, biópsia excisional.
- B)** Timoma invasivo, biópsia com agulha lancetante orientada por tomografia computadorizada.
- C)** Teratoma, biópsia excisional (cirurgia com retirada de toda a massa).
- D)** Tumor de células germinativas tipo seminoma, biópsia excisional.
- E)** Linfoma, videocirurgia com biópsia e se possível ressecção total da massa.

30. Considere um paciente de 55 anos, masculino, grande fumante há mais de 20 anos e sem história prévia de neoplasia. Realizou exame radiológico do tórax que evidenciou um nódulo pulmonar solitário. O nódulo apresenta as seguintes características na tomografia computadorizada (CT): 2,5 cm de diâmetro, na medular, bordos irregulares, presença de calcificação periférica e ganho de 25 UH (Unidade Haunsfield) com a injeção de contraste. Qual a melhor conduta a ser adotada?

- A)** Observação e nova CT em três meses.
- B)** Lobectomia e linfadenectomia mediastinal.
- C)** Segmentectomia e biópsia de congelação que se positiva para malignidade indica lobectomia e linfadenectomia mediastinal.
- D)** Punção pulmonar transparietal e se esta for negativa = observação.
- E)** Videotoroscopia e realização de segmentectomia.

31. Com relação à úlcera de perna hipertensiva ou úlcera de Martorell, é correto afirmar que:

- A)** Tem como base a lesão arterial por aterosclerose.
- B)** A dor melhora quando o paciente deita em posição de Trendelenburg.
- C)** O tratamento ideal para cura da úlcera é o enxerto livre de pele.
- D)** A simpatectomia lombar leva à cicatrização e cura definitiva da úlcera.
- E)** Ocorre, preferencialmente, na face lateral da perna de mulheres hipertensas.

32. O local mais comum de localização de êmbolos nas obstruções arteriais agudas é:

- A)** Bifurcação da braquial.
- B)** Bifurcação da artéria ilíaca.
- C)** Bifurcação da artéria femoral comum.
- D)** Artéria femoral superficial ao nível do canal dos adutores.
- E)** Artéria poplítea ao nível da interlinha articular do joelho.

33. Com relação a semiologia vascular, assinale a alternativa correta.

- A)** O endotélio do capilar linfático é semelhante ao do capilar venoso.
- B)** Vasoconstrição com hiperidrose é sinal de hiperatividade simpática.
- C)** Rubor cutâneo com diminuição da temperatura indica circulação colateral eficiente.
- D)** Cianose intermitente é sinal de inviabilidade tissular.
- E)** O aumento no tempo de enchimento venoso traduz um déficit de circulação venosa.

34. Qual o indicador mais sensível que nos possibilita suspeitarmos da existência de fístula no pós-operatório imediato de Gastroplastia By-pass gástrico laparoscópico para o tratamento da Obesidade Mórbida?

- A)** febre
- B)** oligúria
- C)** leucocitose
- D)** taquicardia
- E)** dor abdominal

35. Acredita-se que a infecção pelo H. Pylori desempenhe importante papel na patogênese de todas as seguintes patologias, exceto:

- A)** esofagite de refluxo.
- B)** úlcera duodenal.
- C)** linfoma gástrico.
- D)** úlcera gástrica.
- E)** adenocarcinoma gástrico.

36. Uma paciente, 30 anos, portadora de úlcera péptica recorrente apresenta elevados índices séricos de gastrina. O mais provável local do tumor é:

- A)** fígado.
- B)** pâncreas.
- C)** estômago.
- D)** duodeno.
- E)** linfonodo.

37. Indique o melhor exame para confirmar a presença de Necrose Pancreática Infectada na pancreatite aguda:

- A)** Endoultrassonografia.
- B)** Ultrassom de abdômen.
- C)** Tomografia computadorizada de abdômen.
- D)** Elevação dos níveis séricos da lipase na segunda semana.
- E)** Punção percutânea por agulha.

38. A bactéria mais comumente identificada na Sepsis de origem no trato biliar é:

- A)** Enterococos.
- B)** Escherichia coli.
- C)** Bacteroides fragilis.
- D)** Enterobacter fragilis.
- E)** Estafilococos coagulase-negativo.

39. A anomalia mais frequentemente encontrada durante a dissecação inicial do pilar diafragmático para a realização da Fundoplicatura Laparoscopica (Nissen) é:

- A)** Artéria frênica inferior direita.
- B)** Artéria hepática comum anômala.
- C)** Artéria hepática direita aberrante.
- D)** Artéria hepática esquerda aberrante.
- E)** Bifurcação proximal da artéria hepática comum.

40. Durante a realização de Colecistectomia Laparoscópica numa paciente de 40 anos, a Colangiografia intraoperatória identificou a presença de litíase com 6 mm de diâmetro no interior do colédoco. A melhor maneira para resolver essa situação é:

- A)** Exploração laparoscópica transcística do colédoco.
- B)** Exploração do colédoco após conversão para laparotomia.
- C)** Exploração laparoscópica do colédoco através de coledocotomia.
- D)** Lithotripsia pós-operatória.
- E)** Observação.

GABARITO

1 - C	2 - A	3 - D	4 - A	5 - B
6 - E	7 - D	8 - C	9 - E	10 - D
11 - C	12 - B	13 - A	14 - C	15 - E
16 - D	17 - E	18 - B	19 - C	20 - D
21 - A	22 - A	23 - C	24 - D	25 - E
26 - A	27 - B	28 - E	29 - B	30 - C
31 - E	32 - C	33 - B	34 - D	35 - A
36 - D	37 - E	38 - B	39 - D	40 - A